ST. LUKE'S ICU ／ EXECUTIVE SUMMARY

ICUの嚥下障害 — 要約

解説「ICUの嚥下障害」の要点を絞った2ページ版。「詳しく」から本編へ。

聖路加国際病院 集中治療科 ／ 対象：研修医・専攻医・看護師 ／ 最終更新 2026-10-10

1 持ち帰る3点

詳しく

症状ではなく手順で拾う

誤嚥の半数超はむせない。抜管は気道保護で決め、不合格を絶食の判決にしない

中身より着手の早さ

治療で確実に減るのは肺炎だけ。1日遅れるごとに調整OR 1.09

回避策の代償を知る

誤嚥性肺炎はAMPC/CVAを5日。絶食・胃管・カフは無害な回避策ではない

2 ICUでは機序が重なり、症状では拾えない

詳しく

- **壊れる機序は6つ**：口腔咽頭・喉頭の外傷、神経筋の筋力低下、喉頭感覚の低下、意識の変容、胃食道逆流、呼吸と嚥下の非同調。抜管直後の患者は複数を同時に持つ
- **絶食でも唾液は誤嚥する**：健常者は1日1,000回を超えて飲み込み、主な目的は約0.5 mL/分で出る唾液の除去
- **頻度は3〜62%**（抜管後は20〜84%、気管切開では93%）。幅は病態ではなく測り方の違い
- **silent aspirationが50%超**：咳もつかえ感も湿性嗄声もないまま、画像で誤嚥が見つかる。「むせなかった」を判断材料にしない

道具	使い方	読み方
3オンス水飲みテスト	90 mLを中断せず飲む。飲みきれない・1分以内の咳やむせ・流涎か湿性の声で不合格	感度96.5%・特異度48.7%。不合格の約半数は誤嚥していない＝STへの入口
FEES・VFSS	疑ったら器械で確かめる	所見はPAS（どこまで入ったか×出せたか、8段階）で残す
下顎の可動性	高齢者の下顎角を指で支え、約1 cm以上動けば可動性あり	可動性ありは退院時の常食5.3%（なし50.1%）。食形態が下がる側の徴候

3 抜管は呼吸ではなく気道保護で決め、抜管後は状態から順に

詳しく

抜管前：咳嗽・絞扼反射・嚥下・追視の4項目を口頭で言い切る

▼ 脳損傷の抜管失敗の67%は分泌物過多。RSBI・P/F・$PaCO_2$は成功と失敗で差がなかった

抜管後：時間ではなく状態

- 覚醒と座位保持がNoなら、絶食のまま再評価
- Yesなら高リスク項目を確かめて水飲みテストへ

その日のうちに着手

- STを待たず、訓練を受けたICUスタッフがスクリーニング
- 再挿管の91%は抜管後5日以内。この間は再評価を続ける

▼

不合格はSTへ。治療開始が1日遅れるごとに遷延性嚥下障害または院内死亡の調整OR 1.09

- **治療の期待値を下げる**：22試験のレビューで減ったのは肺炎だけ（RR 0.71）、誤嚥と経口再開は動かない。それでも抜管後の嚥下リハは迷わず始める（経口再開が0.85日早まり、肺炎はOR 0.24）。器具が要らず害の少ない舌口蓋抵

抗・顎引き抵抗・呼吸筋の訓練から選ぶ

4 誤嚥性肺炎は2要件で診断し、AMPC/CVAを5日

詳しく

- **診断**：①急性下気道感染の徴候と新しい浸潤影による肺炎に、②嚥下障害・誤嚥の証拠かリスク因子を伴う背側の病変を合わせる。画像はまず造影なしの胸部CT。抗菌薬の対象は化学性肺臓炎や機械的閉塞ではなく、この誤嚥性肺炎だけ
- **誤嚥の直後に抗菌薬を始めない**：ARDSがなければ48〜72時間観察し、診断基準を満たしたときだけ開始。ステロイドも吸入も足さない
- **AMPC/CVAを経口優先で**：嫌気性菌は記録された感染の2〜4%で、メトロニダゾールやクリンダマイシンは足さない。72時間で安定していれば5日で終え、膿瘍・膿胸がなければ7日を超えない
- **予防は絶食ではない**：体位・口腔ケア・薬の棚卸し。85歳以上は院内死亡39.3%（JIPAD）で、発症を治療方針を話し合う契機にする。重症例・VAPは重症市中肺炎の考え方に従う

5 経鼻胃管と気管切開 — 無害な回避策ではない

詳しく

- **経鼻胃管は嚥下を妨げる**：留置中は舌骨の移動距離が0.81 cm、抜去30分後に1.14 cmへ戻る。誤嚥性肺炎の再発も防がない。入れにくければ側臥位（初回成功66.7%→89.3%）。カプノグラフィは気道を除外するだけで、初回使用前はX線で確かめる
- **気管切開ではカフを脱気して食べさせる方向へ**：カフ圧は既定26 cmH_2O（文献20〜30）、離脱中は脱気（不顕性誤嚥は膨張23%対脱気7%）。スピーチバルブはカフを完全に脱気してから付ける。抜去は24時間キャッピングではなく、8時間あたり吸引2回以下で判断（REDECAP：抜去まで13日→6日）

- ☐ **胃管の留置日数**を毎日数え、抜く日を回診の議題にする
- ☐ **声帯**：抜管後の喘鳴と繰り返す誤嚥では神経筋疾患を疑う
- ☐ **単呼吸カウント25未満**で呼吸筋力低下を疑い、吸気と咳を別々に評価
- ☐ **申し送り**は「経口不可」でなく、今の段階と次の評価の予定

出典：本編の主要文献（Macht CCM 2013；Godet 2017；Suiter 2008；Duncan ICM 2020；SKR/SRLF 2026；仏感染症学会 IDNow 2025；REDECAP 2020；JIPAD JIC 2026 ほか）。嚥下障害の治療はエビデンスが薄い領域なので、方針の根拠にする前に本編と原著で確かめてください。